

母子保健

環境労働衛生学 上島通浩

母子保健の衛生公衆衛生学における位置づけ

- 妊娠・出産・子育ては、個人や家族の出来事であると同時に、公衆衛生上の課題
- 晩婚化、少子化、育児負担、産後うつ、虐待予防など、多くの社会課題と関係
- 医療だけで完結しない。保健・福祉・教育との連携が必要

妊娠反応が陽性だった。さて・・・

- 仕事どうしよう？
- 産休・育休？
 - とれる？制度はどうだったっけ？
- 次、どうしよう？まずは産婦人科へ・・・
- 妊婦健診、どんなことするのか？
- 実家の支援は限られている。出産後の家事・育児はどうしよう？

妊娠届出書



母子保健法

（妊娠の届出）

第十五条 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

※罰則はない

妊娠届出書

妊娠届出書		母子健康手帳 番号	
高洲市 長 崎		届出年月日	
【ふりがな】	生年月日	年齢	職業
妊婦氏名			個人番号
【ふりがな】	①姓 ②姓 ③(入籍予定、あり、なし)	年 月 日	
【ふりがな】	氏名	生年月日	年齢
【パートナー】		年 月 日	
居住地	(市)	電話	()
		携帯電話	()
	年 月 日	妊婦週数	週 () 日 ()
既往又は胎前 の診断結果 の記載内容 と経過 を記入する	分娩予定日	年 月 日	既往に關する健康診断の有無 ①受けた ②受けていない
	特記事項	①早産 ②多胎 ()	③既往に關する健康診断の有無 ①受けた ②受けていない
			④分娩 ⑤胎前 ⑥その他
	健康診断の受診状況 を記入する		健康診断 の受診 状況を 記入する
			①受診 ②受診 ③受診 ④受診 ⑤受診 ⑥受診 ⑦受診 ⑧受診 ⑨受診 ⑩受診 ⑪受診 ⑫受診 ⑬受診 ⑭受診 ⑮受診 ⑯受診 ⑰受診 ⑱受診 ⑲受診 ⑳受診 ㉑受診 ㉒受診 ㉓受診 ㉔受診 ㉕受診 ㉖受診 ㉗受診 ㉘受診 ㉙受診 ㉚受診 ㉛受診 ㉜受診 ㉝受診 ㉞受診 ㉟受診 ㊱受診 ㊲受診 ㊳受診 ㊴受診 ㊵受診 ㊶受診 ㊷受診 ㊸受診 ㊹受診 ㊺受診 ㊻受診 ㊼受診 ㊽受診 ㊾受診 ㊿受診
※以下の項目は必ず記入してください。欄外から記入する。欄外記入が済むまで、下記以下に記入を続けます。			
1 現在、妊娠経過が正常です。	①はい	②いいえ (理由)	
2 今までにお産の経験はありません。	①初産	②経産 (出産回数 回)	
3 現在、早産を心配しています。	①はい	②いいえ (原因 ①早産 ②死産 ③中絶 ④)	
4 今回の妊娠は予定外妊娠となりました。	①はい	②いいえ	
5 今回の妊娠が分かった時はおなまえをおなまえでしました。	①うしろした	②予想外だったうしろした	
6 予想外だったのでもうなった ③困った ④おなまえと異なる	①はい	②いいえ	
7 産婦の予定は遅れました。	①はい	②いいえ	
8 困った原因に挙げられる人はいます。	①はい (人)	②いいえ	
9 現在、困っていること①悩んでいること②不安なこと③などがあります。	①はい	②いいえ	
④不安()の理由、困っていること⑤悩んでいること⑥不安なこと⑦などがあること⑧不安なこと⑨悩んでいること⑩不安なこと⑪悩んでいること⑫不安なこと⑬悩んでいること⑭不安なこと⑮悩んでいること⑯不安なこと⑰悩んでいること⑱不安なこと⑲悩んでいること⑳不安なこと㉑悩んでいること㉒不安なこと㉓悩んでいること㉔不安なこと㉕悩んでいること㉖不安なこと㉗悩んでいること㉘不安なこと㉙悩んでいること㉚不安なこと㉛悩んでいること㉜不安なこと㉝悩んでいること㉞不安なこと㉟不安なこと㊱不安なこと㊲不安なこと㊳不安なこと㊴不安なこと㊵不安なこと㊶不安なこと㊷不安なこと㊸不安なこと㊹不安なこと㊺不安なこと㊻不安なこと㊼不安なこと㊽不安なこと㊾不安なこと㊿不安なこと			

法令上の届出事項としての部分と、要支援妊婦を把握するための問診・アンケート部分がある

[illegible]

市町村から母子健康手帳が交付される



(名古屋市HPより)

(母子健康手帳)

第十六条 **市町村**は、妊娠の届出をした者に対して、**母子健康手帳を交付**しなければならない。

2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。

妊娠期から乳幼児期までの健康情報を、本人・家族・医療機関・自治体が共有するための縦断的な記録媒体

保健指導と健康診査を受ける





ページID1008954 更新日2024年7月8日

印刷 大きな文字で印刷

両親学級

予約センターでは、妊婦の方を対象に、両親学級を実施しています。

学級の場合同様のため、事前にご確認ください。ご来場でご参加いただける内容もありますので、ぜひご参加ください。

＜ 妊娠中の生活で気を付けたいこと ＞

妊婦健康診査

対象者

名古屋市に住所を有する妊婦

公費負担回数

14回

多胎児を妊娠した妊婦様については、追加で5回の産前産後を行います。

内容

- 第1回

一般診察（問診・血圧測定・尿検査）
胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）
胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）
胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）
- 第2回

胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）
胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）
胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）
胎動・胎位・胎心・子宮収縮（胎動・胎位・胎心・子宮収縮）

(名古屋市内HPより)

(名古屋市HPより)

(保健指導)

第十条 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。

(健康診査)

第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

赤ちゃんが生まれたら出生届とともに 出生報告をする

出生報告

出生報告

赤ちゃんが生まれたら、保健センターへ**出生報告**をお出しください。

この**出生報告**は、「母と子の健康のために」という冊子(母子健康手帳別冊)の中にあります。

なお、体重が2,500g未満の小さな赤ちゃん(低体重児)や出産時のご様子で心配なことがある赤ちゃんは、特に早めに**出生報告**をお出しいただき、お知らせください。

提出された内容を確認後に、保健センターから連絡をして新生児児訪問をします。

新生児児訪問

新生児児訪問

保健センターでは、赤ちゃんのお生まれになったすべてのご家庭への家庭訪問を行っています。

保健師や助産師が訪問し、赤ちゃんの発育やお母さんの産後の体調、子育て等のご相談をお受けしています。

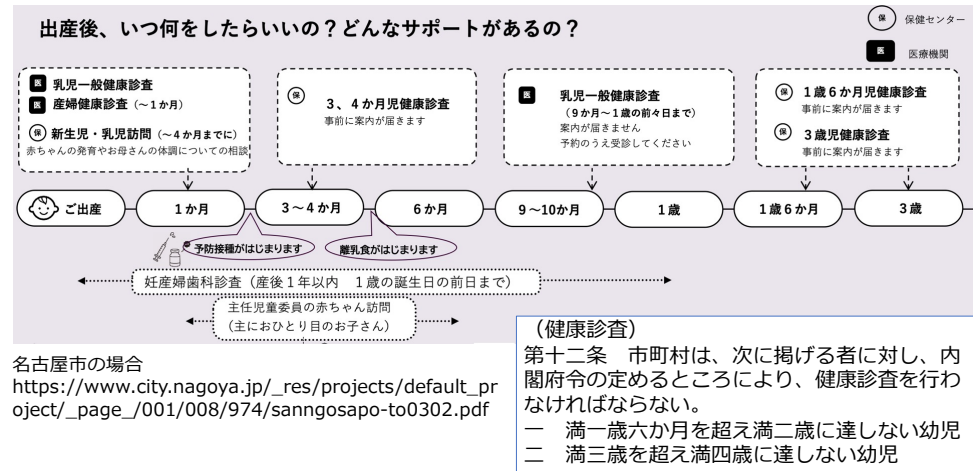
対象

生後4か月ごろまでの赤ちゃんとそのお母さん

内容

赤ちゃんの体重測定、赤ちゃんの発育発達や子育てに関する相談、産後のお母さんの体調に関する相談等

出産後、母と子の健康診査を受ける



母子保健の仕組みとしての視点

妊娠・出産した人の行動	行政側視点・公衆衛生的位置づけ
市町村への妊娠届の提出・市町村から母子健康手帳が交付される	妊娠を社会的に把握
保健指導を受ける	妊婦と定期的に接点を持つ
妊婦健診の受診	妊娠経過の異常を早期発見する
産婦健診の受診	産後うつ・育児困難を発見する
新生児・乳児訪問（指導）を受ける	医療・福祉につなぐ
乳幼児健康診査を受ける	発達障害、聴覚・視覚障害、虐待リスク、養育困難、保護者のメンタルヘルス問題などを拾う

母と子の健康状態を集団指標で評価する

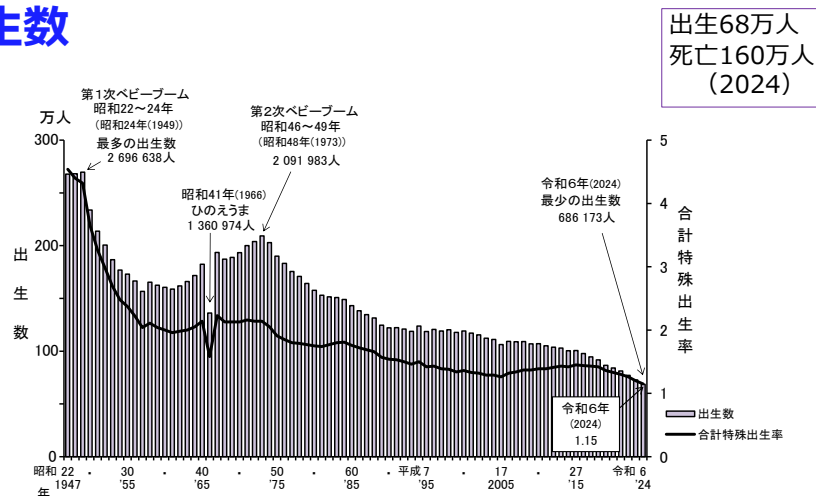
母子保健水準の指標

- 出生
- 妊産婦死亡
- 死産
- 新生児死亡
- 周産期死亡
- 乳児死亡
- 小児死亡

出産と出生

- 出産 = 出生 + 死産
- **出生**：すべての出産のうち、胎児が生存して生まれた場合の出産
- **死産**：妊娠満12週以後の死児の出産

出生数



NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

(粗) 出生率と合計特殊出生率 (人工千対)

- 粗出生率：5.7 (2024年)
- 合計特殊出生率 = (母の年齢別出生数 / 該当年齢日本人女子人口) の15歳～49歳の合計：1.15 (2024年)
 - 15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもの
 - 一人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子供の数
 - 粗再生産率とも呼ばれる
 - 現在の人口を維持するためには2.07が必要

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

再生産率

総再生産率

- 総再生産率 = (母の年齢別女子出生数 / 該当年齢日本人女子人口) の15歳～49歳の合計
- 0.59 (2023年)

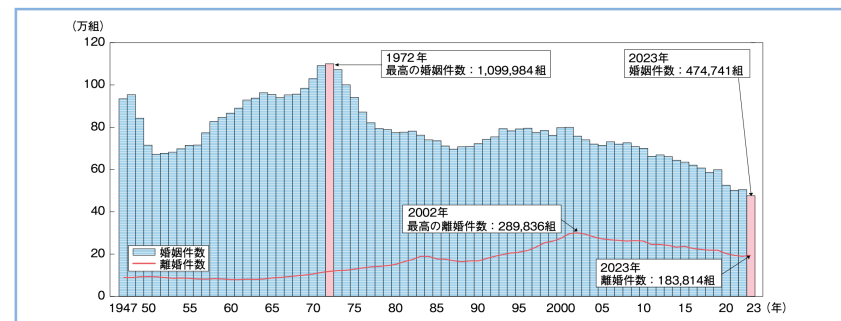
純再生産率

- 総再生産率に生まれた女兒が妊娠可能な年齢を過ぎるまでの死亡率を見込んだもの
- 0.58 (2023年)

1 より大きければ将来人口は増加する

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

図表 2-1-2 婚姻件数及び離婚件数の年次推移



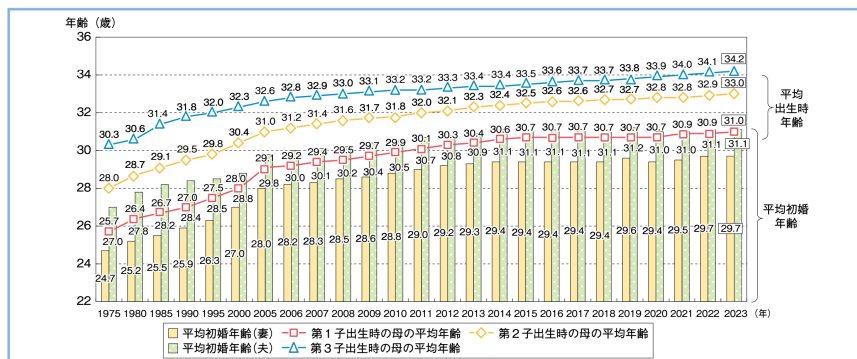
(出典) 厚生労働省「人口動態統計」(確定数)

平均初婚年齢 夫31.1歳、妻29.7歳 (2023年)

出典：こども家庭庁 令和6年度 我が国におけるこどもをめぐむ状況及び政府が講じたこども施策の実施状況 (令和7年度版こども白書)

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

図表 2-1-3 平均初婚年齢と出生順位別出生時の母の平均年齢の推移



(出典) 厚生労働省「人口動態統計」(確定数)

(注) 「平均初婚年齢(妻)・(夫)」は、出典統計の「当該年に結婚生活に入り届け出たもの」の値で算出したもの。

晩産化：第1子出生時の母親の平均年齢31.0歳

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

妻が子どもを持つことを理想と考える理由 (2021年第16回出生動向基本調査)

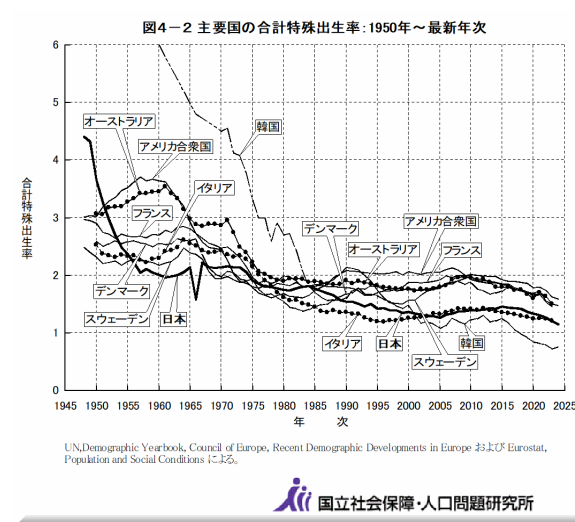
1. 子どもがいると生活が楽しく豊かになるから (80.0%)
2. 好きな人の子どもを持ちたいから (40.9%)
3. 結婚して子どもを持つことは自然なことだから (33.8%)
4. 子どもは将来の社会の支えとなるから (19.2%)
5. 子どもは夫婦関係を安定させるから (16.9%)
6. 子どもは老後の支えになるから (15.5%)
7. 夫や親など周囲が望むから (14.1%)
8. 子どもを持つことで周囲から認められるから (4.5%)

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

理想の子供の数を持たない理由 (2021年第16回出生動向基本調査)

1. 子育てや教育にお金がかかりすぎるから (52.6%)
2. 高齢で産むのは嫌だから (40.4%)
3. 欲しいけれどもできないから (23.9%)
4. これ以上、育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから (23.0%)
5. 健康上の理由から (17.4%)
6. 自分の仕事に差し支えるから (15.8%)
7. 夫の家事育児への協力が得られないから (11.5%)
8. 家が狭いから (9.4%)
9. 夫が望まないから (8.9%)
10. 自分や夫婦の生活を大切にしたいから (8.2%)
11. 一番末の子が夫が定年退職までに成人してほしいから (6.7%)
12. 子どもがのびのび育つ環境ではないから (5.0%)

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School



引用元：
https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2026.asp?fname=G04-02.gif

国立社会保障・人口問題研究所

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

妊産婦死亡

- 妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡
- 直接産科的死亡：妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したもの（子宮外妊娠、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、妊娠高血圧症候群など）
- 間接産科的死亡：妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したもの（糖尿病、心血管疾患など）

妊産婦死亡率（出産10万対）

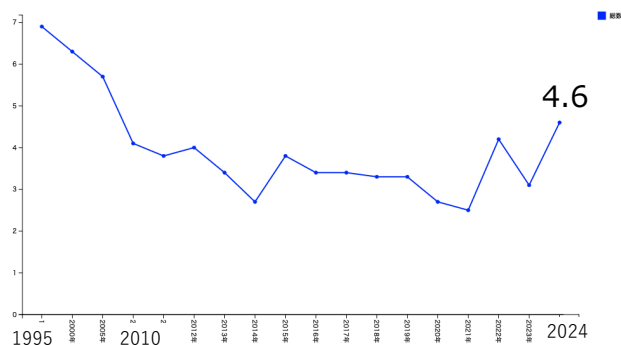
$$\frac{\text{妊産婦死亡数}}{\text{出産数}} \times 100,000$$

（出生数 + 妊娠満12週以後の死産数）

国際比較のためには

$$\frac{\text{妊産婦死亡数}}{\text{出生数}} \times 100,000$$

妊産婦死亡率の年次推移（1995～2024年）



死産：妊娠満12週以後の死児の出産

- 人工死産
胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置（胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用）を加えたことにより死産に至った場合
- 自然死産
人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。
 - (1) 胎児を出生させることを目的とした場合
 - (2) 母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合

死産率(出産千対) : 21.8 (2024年)

$$\frac{\text{死産数}}{\text{出産数}} \times 1,000$$

分母が「出生数」の場合は「死産比」と呼ぶ

- 妊娠期間別の死産数は、自然死産では満12-15週で最も多く、人工死産では満16-19週で最も多い
- 母の年齢別の死産率は、自然死産では25-29歳、人工死産では30-34歳が最も低く、より若年あるいは高齢になるほど高率になる (2024年)

周産期死亡

- 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡 (生後1週未満の死亡) を加えたもの
- とともに母体の健康状態に強く影響される

周産期死亡率 (千対) : 3.3 (2024年)

$$\frac{\text{妊娠満22週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{\text{出生数} + \text{妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

乳児死亡率 (新生児死亡率・早期新生児死亡率) (出生千対)

$$\frac{\text{乳児 (新生児・早期新生児) 死亡数}}{\text{出生数}} \times 1,000$$

新生児死亡 : 生後4週(28日) 未満の死亡

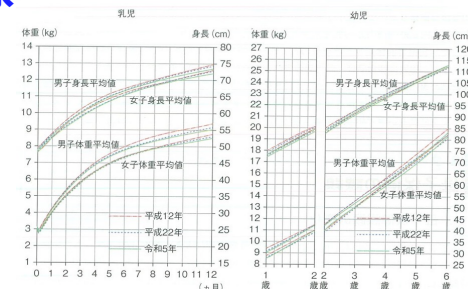
早期新生児死亡 : 生後1週(7日) 未満の死亡

地域の衛生状態や経済・教育を含めた社会状態を反映する指標

乳児死亡率 1.8 (2024年) : 死因第1位は先天奇形、変形および染色体異常

発育に関する指標

- 乳幼児身体発育曲線



- 肥満度とカウプ指数 (BMI)
 - 肥満度(%) = $\frac{[\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}]}{\text{身長別標準体重(kg)}} \times 100$
 - カウプ指数 = $\frac{\text{体重(kg)}}{\text{身長(m)}^2}$

(シンプル衛生公衆衛生学2026: p235)

妊産婦と労働（労働基準法）

- 産前・産後休業：産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）＜女性が請求した場合に限る＞、産後は8週間女性を就業させることはできない（ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえない）。4ヶ月以上（12週以上）の妊娠であれば、生産、死産、流産、早産を問わず適応される。
- 妊婦の軽易業務転換：妊娠中の女性が請求した場合は、軽易な業務に転換させなければならない。
- 妊産婦等の危険有害業務の就業制限：妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできない。
- 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限：妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできない。
- 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限：妊産婦が請求した場合はさせることはできない。
- 育児時間：生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

男女雇用機会均等法

- 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
妊娠中：妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回
産後（出産後1年以内）：医師等の指示に従って必要な時間を確保する
- 指導事項を守ることができるようにするための措置
妊娠中の通勤緩和（時差通勤、勤務時間の短縮等の措置）
妊娠中の休憩に関する措置（休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置）
妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置（作業の制限、休業等の措置）

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

男女雇用機会均等法

- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
 - 解雇 ○期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと ○あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること ○退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと ○降格 ○就業環境を害すること ○不利益な自宅待機を命ずること ○減給、又は賞与等において不利益な算定 ○昇進・昇格の人事考課における不利益な評価 ○派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

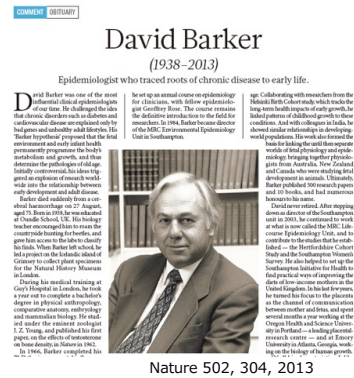
母子保健の課題

- 少子化
- 児童虐待
- 発達障害
- 低出生体重児（2500g未満）：9.8%（2024年）
 - 早期産、胎児の疾病、妊婦の疾病、妊娠中の体重増加不良、妊娠中の喫煙などが原因
- メンタルヘルス：産後うつ、10歳代の自殺
- 子どもの貧困
- 健康格差（都道府県間）：肥満、う蝕、妊婦喫煙率等など
- 子ども（幼児）の事故

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

Barker説からDOHaD説へ

- 「成人病は、胎児期あるいは乳児期の栄養状態により、その素因の約70%が規定され、その後の生活習慣の負荷により発症する」
(成人病胎児期発症説)
- Barker説は概念を拡大して Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) 説へと発展
- 低出生体重児対策、妊娠中の栄養、化学物質、ストレスに対する管理が重要



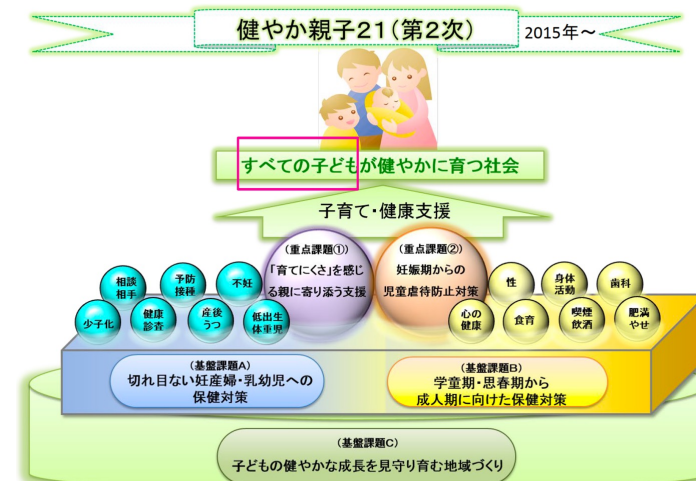
不慮の事故による死亡(2021)

	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳
総数	61	50	45	52
交通事故	1	12	19	18
転倒・転落・墜落		9	2	4
溺死及び溺水	3	13	15	16
窒息	56	11	5	8
煙、火及び火災				
中毒		1		
その他	1	4	3	6



母子保健活動のキーワード

- 切れ目のない支援：妊娠、出産、育児にわたる、健康診査、保健指導、療養援護、医療対策
- 健やか親子21
- 少子化対策
- 児童虐待対策
- 成育基本法
- 子ども家庭庁
- 新生児マス・スクリーニング検査：フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常、先天性副腎過形成症、先天性甲状腺機能低下症の早期発見・早期治療



成育基本法(2019年12月施行)

成育基本法は、**児童の権利に関する条約の精神にのっとり**、成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的としています。成育医療等の提供に関する施策に関する基本理念のほか、国、地方公共団体、保護者、医療関係者などの責務を明らかにするとともに、成育医療等基本方針の策定、基本的施策となる事項などについて定めています



「すべてのこどもが健やかに育つ社会」の実現



<https://sukoyaka21.cfa.go.jp/about/growth-sukoyaka21/>